EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70396
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-09-07 09:23:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN LUIS SEPULVEDA IBANEZ			RUN	: 6.289.898-4
F.Nac	: 29-03-1950	Edad	: 73 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LAS ROSAS SAN GREG.			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 18-08-2023	Fecha Egreso	: 2023-09-07 09:23:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E10.5-DIABETES MELLITUS INSULINODENDIENTE CON COMPL. CIRC. PERIFER

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

amputacion supracondilida derecha
Pie diabetico
Nueva amputacion supracondilia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E10.8-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPL. NO ESPECIFI (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E78.0-HIPERCOLESTEROLEMIA PURA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingreso a urgencia el 18/08/23 derivada desde ñiquen por lesión del 2 y 3
por lo cual se decidio hospitalizar, se opero el 19/08/23 donde se realizo amputacion supracondilia a izquierda sin complicaciones
muñon con tension, sin sangrado, con salida de pus en borde medial escaso por lo cual se decidio antibiotico por 12 dias
se realizo cultivo de secrecion donde se informa + para Enterococcus faecalis sensible a vancomicina, se inicio vancomicina el 5/9/23 por 14 dias
se evidencia de dehiscencia de borde medial, resto de muñon en buenas condiciones, sin salida de secrecion, limpia y seca.

Actualmente paciente en BEG, tranquilo sin dolor
Hemoduinamicamente estable, sin apremio ventilatorio
afebril, diuresis + y deposiciones +.

ex fisico:
Alerta, vigil, OTE
Piel rosada, mucosas hidratadas, llene capilar <2s
Cardiopulñmonar: RR2T NAS. MP+ SRA
abdomen: RHA+ BDI, sin signos de irritacion peritoneal.
EEII: muñon izquierdo con dehiscencia medial, sin salida de secrecion, sin necrosis, sin signos de infeccion resto de muñon en buenas condiciones. muñon derecho en buenas condiciones.

PLAN DE MANEJO:

1.- Mantener curaciones por HODOM
2.- Completar ATB, 12 dias mas

3.- Control en CAE de cirugia

INDICACIONES AL ALTA

1. 1.- Regimen diabetico
2. 2.- Reposo relativo
3. 3.- Curaciones por HODOM
4. 4.- Medicamentos:
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. METAMIZOL COMPRIMIDO 300 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
9. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
10. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
11. ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
12. PREGABALINA COMPRIMIDO 75 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
13. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL
14. VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 2 ampolla cada 12 hrs. por 12 dias via ENDOVENOSA
15. 5.- Control en CAE de cirugia en 21 dias

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO